Disciplina: PEDIATRIA II

Dores recorrentes

Prof. PATRICIA DAHAN

SUPREMA
Faculdade de Ciências Médicas e da Saúde de Juiz de Fora

PLANO DE ENSINO

Curso: Medicina

Data: 2º Semestre de 2023 Período: 8º

Professor: PATRICIA DAHAN

Conteúdo Programático Abordado nesta videoaula:
Dores recorrentes

SUPREMA



Objetivos da aula

- ✓ Definir dor recorrente (DR)
- ✓ Saber como abordar inicialmente um quadro de dor abdominal recorrente, cefaleia recorrente, e dor em membros recorrente
- ✓ Conhecer os sinais de alerta para cada tipo de DR

SUPREMA

- **Aguda: maior descrição**

  (proximidade do evento)

- **Crônica: cronologia pouco clara;**

  (informações incompletas e vagas)



FATORES QUE MODIFICAM A EXPRESSÃO DA DOR NA INFÂNCIA:

- Sexo
- Nível cognitivo (percepção da dor pela criança)
- Experiências dolorosas, prévias e aprendizado
- Padrões culturais.
- Relações familiares; comportamento dos pais
- Repercussões da dor na rotina da criança (ausência às aulas, atividades esportivas, sociais e tarefas domésticas)

- **PERSISTENTE (rara em crianças): sem período assintomático (doença de base?)**
- **RECORRENTE pelo menos 3 episódios durante período de 3 meses, com intensidade suficiente para interferir nas atividades habituais da criança.**

SUPREMA

Outras informações relevantes

- **Manifestações sistêmicas associadas**
- **Comprometimento do estado geral**



CEFALÉIA	20,6%
DOR EM MEMBROS	15,5%
DOR ABDOMINAL	14,4%

J.Ped 79(1), 2003

SUPREMA

10 a 15% das dores recorrentes tem causa orgânica

PORÉM, mesmo com a identificação da causa orgânica

não se deve excluir:

- Aspectos emocionais
- Sociais
- Familiares
- Cognitivos

SUPREMA

Sintomas vagos,
Interpretação subjetiva ,
Pressão dos pais



SUPREMA

“Uma mãe traz seu filho de 7 anos a consulta pediátrica referindo que o menino queixa de dor abdominal há 2 anos, semanalmente, e que já levou a diversos médicos , os quais realizaram vários exames de fezes, todos negativos. Ela está muito preocupada pois ninguém descobre a causa da dor, e apesar de dizerem que não se trata de nada sério, o menino continua a ter dor”.

Atitude simplista
“Não é nada”
Não responde a demanda da família/ Não alivia o sofrimento

Investigação extensa e custos à procura da Etiologia da dor

SUPREMA

Para um diagnóstico,

- **Entender angústia e dúvidas dos familiares**
- **Anamnese e exame físico detalhados**
- **Relato das crianças / entrevistar separadamente dos pais:**

  - *Para conhecer a criança: rotina diária? atividades? relacionamentos com pais, amigos e professores?*

  - *Para conhecer os pais: alguém com dor ou doença crônica? Reação frente a dor da criança? Evento crítico recente? Reação dos pais nos momentos de conflito?*

SUPREMA

Características da dor:

- **Início dos sintomas**
- **Frequência e duração**
- **Tipo(s) de dor(es), localização e irradiação**
- **Intensidade,**
- **Onde e quando ocorre?**
- **Fatores precipitantes, agravantes e de alívio,**
- **Sintomas associados**
- **Tratamentos anteriores**

IDENTIFICAR SINAIS DE ALERTA

SUPREMA

Dor abdominal recorrente:

- **Prevalência : 0,5% a 19%**
- **2 picos de incidência : 4-6 anos e 7-12 anos**
  mais freqüente em meninas na adolescência
- **Queixa freqüente em serviços de urgência**

SUPREMA

- Dor abdominal crônica (DAC) - quadro de dor abdominal de longa duração (usualmente mais de três meses) com padrão contínuo ou intermitente.
- Dor abdominal orgânica (DAO) - quando associada a uma causa anatômica, inflamatória ou dano tecidual.
- Dor abdominal funcional (DAF) - dor abdominal que ocorre na ausência de uma causa anatômica, inflamatória ou dano tecidual.

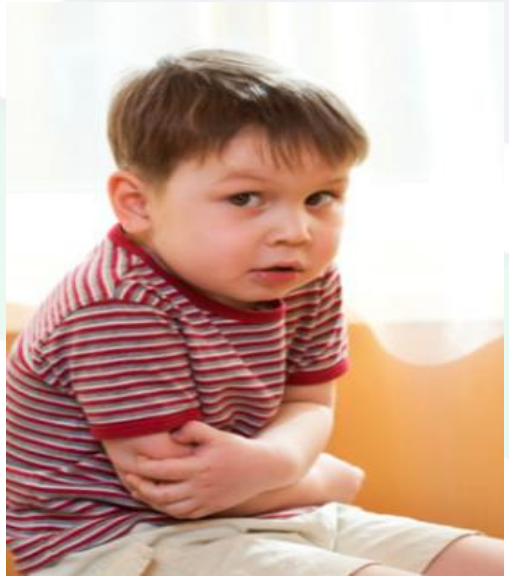
Subcomissão de DAC da AAP

SUPREMA

Dor abdominal recorrente

- **Em 5 a 10% : doenças do aparelho gastrointestinal ou genitourinário**

- **Diagnósticos:**
  - Constipação intestinal
  - Refluxo gastroesofágico
  - Infecção do trato urinário
  - Nefrolitíase
  - Doença péptica
  - Parasitose intestinal
  - Anormalidades anatômicas do TGI ou do TGU
  - Outras



SUPREMA

Dor abdominal recorrente

- **Em 90-95% : Dor abdominal funcional**

  Paroxismos isolados de dor

  Sintomas dispépticos **(Náuseas, plenitude gástrica, distensão, eructações, soluços, saciedade precoce.)**

  Disfunção do tubo digestivo **(diarreia ou constipação)**

Principais disfunções funcionais com dor abdominal

1) **Dispepsia funcional** (plenitude pós prandial ou saciedade precoce; dor epigástrica – sintomas não associados a defecação)

2) **Síndrome do intestino irritável** (dor abdominal relacionada a defecação e associada a mudança na consistência/frequência. Fatores emocionais, dietéticos, farmacológicos ou hormonais podem precipitar ou agravar os sintomas

3) **Enxaqueca abdominal** (episódios paroxísticos de dor abd intensa bem espaçados, associada a náuseas, vômitos , cefaleia, fotofobia, palidez)

4) **Dor funcional sem outra especificação**

SUPREMA

Dor abdominal recorrente

- ANAMNESE
  - Colher dados sobre dor e fatores desencadeantes ,
  - Doença viral recente, Ingesta de certos alimentos, Situações de estresse, ansiedade
  - Uso concomitante ou anterior de medicação,
  - Hábitos intestinais (escala de Bristol)

SUPREMA

Bristol Stool Chart

Type 1		Separate hard lumps, like nuts (hard to pass)
Type 2		Sausage-shaped but lumpy
Type 3		Like a sausage but with cracks on the surface
Type 4		Like a sausage or snake, smooth and soft
Type 5		Soft blobs with clear-cut edges
Type 6		Fluffy pieces with ragged edges, a mushy stool
Type 7		Watery, no solid pieces. **Entirely Liquid**

SUPREMA

Dor abdominal recorrente

ABORDAGEM DIAGNÓSTICA- anamnese

* História familiar de enfermidades gastrintestinais ou sistêmicas (doença inflamatória intestinal ou úlcera peptica)

*Conhecimento global do paciente; Situações geradoras de ansiedade

*Atitude dos pais com o paciente e suas dores (Entrevistar os pais separadamente da criança)

SUPREMA

Diagnóstico:

- Exame completo : estado nutricional, curva de crescimento, estado geral
- Exame cuidadoso do abdome : Presença de massas, visceromegalias e regiões dolorosas à palpação



Sinais de alerta para dor abdominal recorrente:

- **Dor de localização periférica** (distante do umbigo).
- **Dor que se irradia** para as costas, escápula ou membros inferiores.
- Dor que repetidamente **desperta a criança do sono.**
- **Outras evidências de doença orgânica e/ou exame físico** com perda de peso, parada ou desaceleração do crescimento, febre recorrente de origem indeterminada, vômitos significantes ou biliosos, visceromegalias, massas abdominais, anormalidades perianais, diarréia crônica, artrite, melena …..
- **História familiar de doença orgânica** como doença péptica, doença inflamatória intestinal ou doença celíaca.
- **Alterações nos exames laboratoriais**: aumento VHS, PCR, anemia, leucocitose, alterações na análise de urina.

SUPREMA

EXAMES COMPLEMENTARES – pensando em dor abdominal ORGÂNICA

Nível 1

Hemograma
VHS/ PCR quantitativa
Urina rotina/urocultura
Exame parasitológico de fezes

Outros exames de acordo com a suspeita de causa orgânica

- Teste de tolerância a lactose
- Endoscopia digestiva alta
- Ultra-sonografia de abdome ou tomografia de abdome

Outros: de acordo com suspeita de causa orgânica

SUPREMA

Terapêutica:

- Abordagem ambulatorial detalhada
- Anti-parasitário (?)
- Identificar a causa e tratar especificamente
- Remissão em 30% dos casos nos primeiros 6 meses de acompanhamento
- Recidivas frequentes e surgimento de dores recorrentes em membros ou cefaléia

- **Orientar pais sobre sinais de alerta**

SUPREMA

Dores recorrentes em membros:

- Mais frequentes em escolares
- 4 a 10 anos
- Discreto predomínio nas meninas
- **Causa orgânica rara: 3 a 4%**
- CONCEITO: pelo menos três episódios de dor, de intensidade suficiente para interferir nas atividades habituais da criança, por um período de pelo menos três meses
- Geralmente dores difusas e não articulares / mais comum : membros inferiores

SUPREMA

Causas mais frequentes sem manifestações sistêmicas



- “Dor de crescimento”
- Fibromialgia
- Hipermobilidade articular
- Alterações estruturais e posturais
- Dores localizadas: osteocondrites; síndrome do superuso e tumores ósseos.

SUPREMA

DOR DE CRESCIMENTO (dor recorrente em membros não específica)

- 6-13 anos de idade
- Dor musculo esquelética intensa em ambos os membros inferiores (face anterior da coxa, região poplítea, panturrilhas ou região periarticular)
- 10 a 15 minutos,geralmente final da tarde mas pode acordar a criança
- **Dificuldade em localizar**
- **Sem outras queixas ou comprometimento**
- **Melhora com calor, massagem ou analgésicos**
- Piora com frio, atividade física e disturbios emocionais
- **Exame físico , laboratorial e radiológico: normais**



SUPREMA

FIBROMIALGIA

- Mais adolescentes , sexo feminino
- Dor musculo esquelética difusa, intermitente, geralmente **associada a alterações de humor , distúrbios do sono e fadiga**
- **Critérios para diagnóstico**: dor à digito pressão de pontos determinados (escápula, cotovelo, joelho)

SUPREMA

SÍNDROME DA HIPERMOTILIDADE ARTICULAR



- Maiores de 5 anos
- **Hipermotilidade articular generalizada** associada a dores musculoesqueléticas (semelhantes a dor do crescimento).
- Pode ter artralgia em 1 a 2 articulações (quadris, joelhos, tornozelos ou cotovelos)
- **Excelente desempenho em atividade física**
- Mas **quedas frequentes**
- Exame físico com frouxidão excessiva das estruturas ligamentares das articulações / **critérios diagnósticos**

SUPREMA

SÍNDROMES DE SUPERUSO

- **Atividades esportivas ou utilização excessiva de computador e jogos eletrônicos**
- Esforço repetitivo levando a **microtraumatismos** e podendo causar incapacidade funcional

- Evolui para dor constante que piora com atividade.
- **Radiografias sem alterações significativas**
- Racionalizar atividade física e uso do computador

SUPREMA

TUMORES ÓSSEOS

- **dor recorrente em membros localizada,**
- **unilateral e fixa no local da lesão**
- Metade dos tumores ósseos primários na infância são malignos (1% das neoplasias malignas) mais frequentes osteosarcoma e sarcoma de Ewing
- **Alterações radiológicas sugestivas**
- Diagnóstico definitivo : biopsia óssea

SUPREMA

Causas de dor em membros com manifestações sistêmicas

- Doença do tecido conjuntivo,
- Hipovitaminoses (raquitismo),
- Doenças endócrinas como hipotireoidismo, hiperparatireoidismo (desmineralização óssea);
- Hemoglobinopatias (anemia falciforme)

SUPREMA

Diagnóstico:

- Anamnese e exame físico detalhados

- Exame fisico:
  - avaliação da postura, marcha,
  - semiologia articular (inspeção, palpação, movimentação ativa e passiva das articulações),
  - palpação de pulsos periféricos, medida de comprimento dos membros, avaliação da força muscular.

- Encaminhamento ao ortopedista

SUPREMA

Laboratório:

- Hemograma completo
- Prova inflamatória da fase aguda (PCR / VHS)
- Radiografia simples
- Aprofundar se presença de sinais de alerta

SUPREMA

Sinais de alerta para dor em membros :

- Dor localizada em pontos fixos (mas que não fazem parte dos critérios de fibromialgia)
- Dor com características diferentes: parestesias , formigamento…
- Dor a palpação muscular ou movimentação passiva.
- Diminuição da força muscular.
- Dificuldades ou alterações da marcha como claudicação ou recusa para andar
- Manifestações sistêmicas como febre, palidez, perda de peso, etc…
- Persistência da dor e/ou não resposta a analgésicos

SUPREMA

Tratamento:

- Identificar a causa : tratamento específico (ex: na fibromialgia, anti inflamatórios)

- Prognóstico benigno e autolimitado na maioria dos casos

SUPREMA

Cefaléia recorrente

- Importante causa de absenteísmo escolar
- Prevalência de 20% ; predomínio em meninas
- **Cefaléias primárias:** aquelas que não são decorrentes de doenças orgânicas específicas; são as mais frequentes em pediatria: **migrânea e cefaléia do tipo tensional**

SUPREMA

Migrânea



- Moderada/ forte intensidade
- interferindo nas atividades diárias
- Acompanhada de nâuseas e vômitos, fotofobia, fonofobia e ocasionalmente por manifestações neurológicas transitórias como parestesia, paresia etc…
- 3-18 anos: 7,7-17,8% (9,7% em meninas e 6% em meninos)
- Base hereditária mas desencadeantes como estresse, ansiedade, calor, alguns alimentos, flutuações hormonais etc
- Geralmente dura 1 até 72 hs/ bifrontal, biparietal ou unilateral

SUPREMA

Migrânea

- Geralmente sem aura e associada a naûseas, vômitos e dor abdominal
- Enxaqueca com aura geralmente em adolescentes: sintomas visuais por 5 a 60 minutos antes ou durante a dor.
- Em crianças pequenas : diagnóstico mais difícil palidez facial, vômitos ocasionais, perda de apetite, intolerância à luz ou ruído e irritabilidade.



SUPREMA

Cefaléia tensional

- Dor contínua que pode limitar mas não atrapalhar as atividades diárias
- Dor em aperto ou pressão , geralmente bilateral
- Pode durar de 30 minutos até 7 dias
- Ausência de nâuseas, vômitos, fotofobia e fonofobia
- Melhora com sono
- Diagnóstico geralmente de exclusão
- Fatores desencadeantes: tensão familiar, ocorrência de eventos críticos, dificuldades escolares, dores crônicas em familiares etc

SUPREMA

Cefaléias secundárias

- Apenas 5% das cefaléias recorrentes em crianças são secundárias a doença orgânica
- Causas: hipertensão arterial, sinusites.
- **Causas oftalmológicas são superestimadas**
- **Maior medo : PROCESSO EXPANSIVO** com Hipertensão intracraniana
  Evolução crônica e progressiva
  - Geralmente dor matutina
  - Exacerba-se com mudanças na posição da cabeça
  - Acompanhada de outros sinais neurológicos (hidrocefalia, paralisia de pares cranianos, sinais meníngeos etc)

SUPREMA

Diagnóstico:

- Anamnese e exame físico
- Medida de pressão arterial e exame neurológico.
- Diário de acompanhamento da dor com perguntas (intensidade, sintomas associados, ingesta de alimentos etc) evolução diária

- Afastar sinais de alerta

SUPREMA

Sinais de alerta para cefaléia recorrente:

- **Alterações neurológicas no exame ou crises epilépticas**
- **Alterações oculares** como edema de papila, anisocoria, nistagno, instalação de estrabismo, diplopia e diminuição da acuidade visual
- **Vômitos persistentes** com aumento na frequência ou de início recente
- Precipitada por esforço físico, manobras de Valsalva ou mudança de postura
- **Mudança no padrão da cefaléia**, com aumento na intensidade e frequência
- **Cefaleia unilateral**
- **Cefaléia recorrente matinal ou repetidamente desperta a criança**
- **Crianças com desaceleração da velocidade de crescimento**
- **Criança com idade inferior a 5 anos (principalmente < 3 anos)**

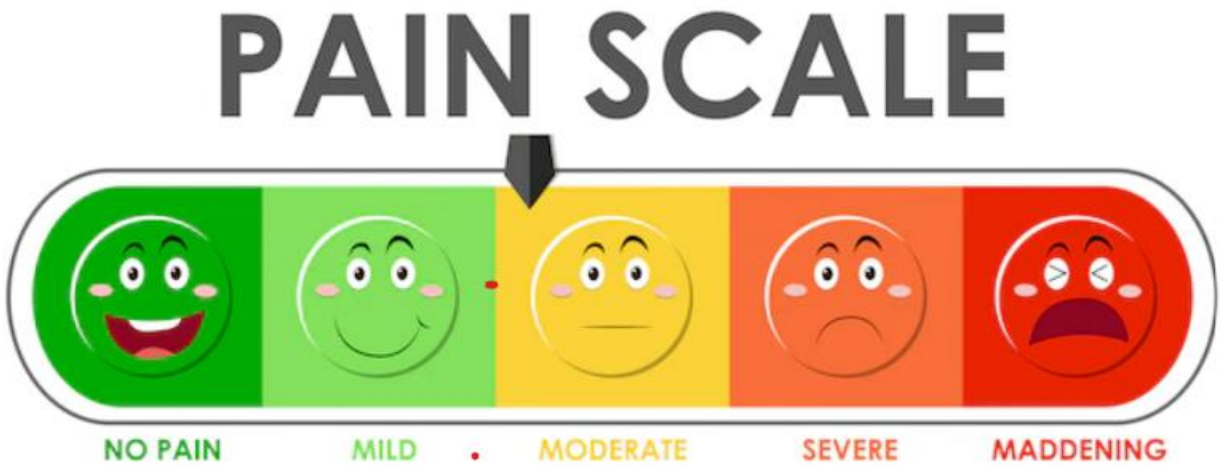
SUPREMA

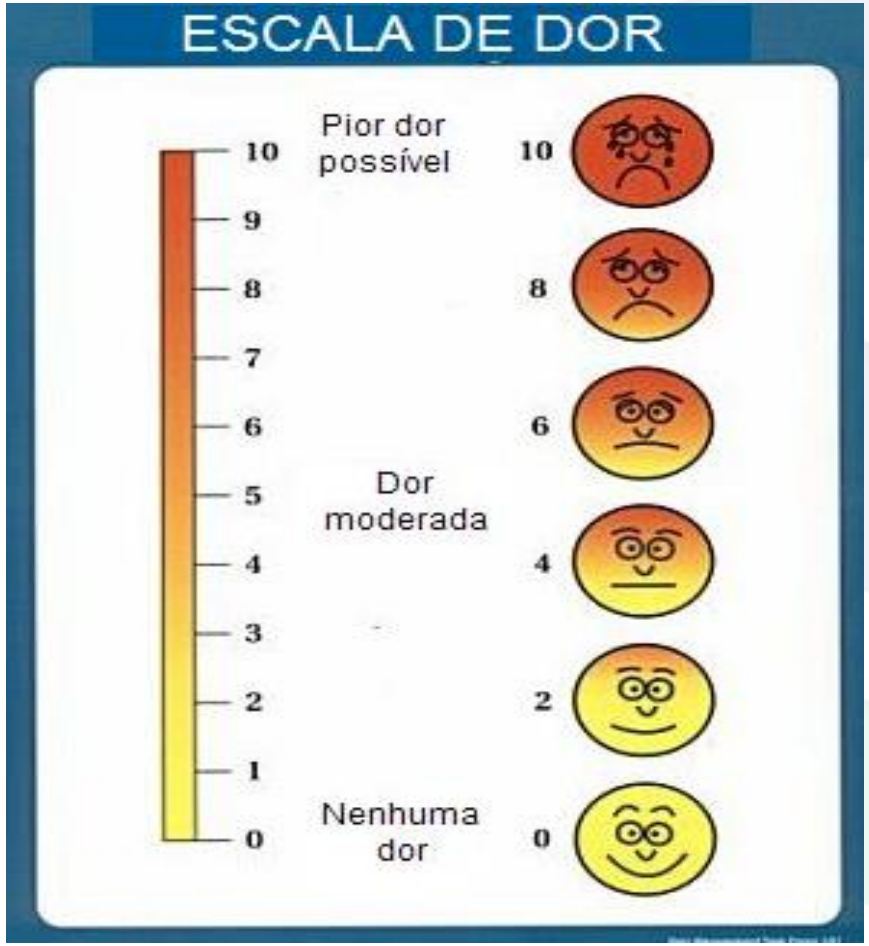
Terapêutica:

- Tratamento de acordo com a causa identificada
- Conhecimento dos fatores precipitantes

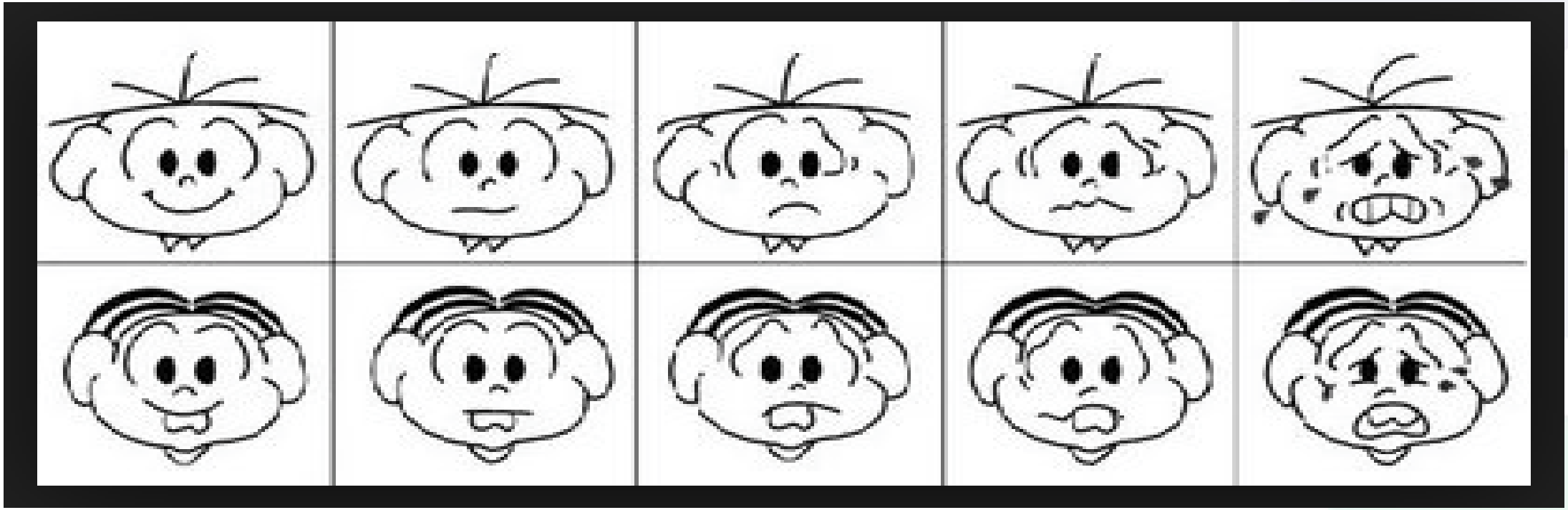
SUPREMA

Escalas de dor





SUPREMA



SUPREMA

Referências

- MARCONDES, E. et al. **Pediatria básica**. São Paulo: Sarvier; 2003.
- LOPES, F.A; DIOCLÉCIO,C.J; BURNS,D.A.R. **Tratado de Pediatria- Sociedade Brasileira de Pediatria.** São Paulo : Manole 3ª Ed. 2017.
- Puccini R.F.; Bresolin A.M.B. Dores recorrentes na infância e adolescência . J.ped, v.79(S65), 2003.

https://www.scielo.br/j/jped/a/VqMHDHFq65DPHRxNY99K5zM/abstract/?lang=pt

SUPREMA